

통 보 사 항

1. 제 목 : 병실 및 인력 운영 등에 관한사항

2. 관계기관 : !!병원

3. 내 용 : !!병원에서는 「의료법」 제33조제4항 및 같은 법 시행규칙 제27조 제2항에 따라 부산광역시 사상구청에 '16.10.10. 현재 546병상(일반병동 504, 완화의료 16, 중환자실 26)을 신고하고 입원환자를 진료하고 있습니다.

가. 병실 운영에 관한사항

!!병원에서 운영중인 병실은 [표 1] 과 같이 일반병동은 1인실, 4인실, 6인실, 8인실로, 완화의료병동은 2인실과 4인실로 이루어져 있습니다.

[표 1] 병실 구성현황

구분	계		1인실	2인실	4인실	6인실	8인실
	병상수	실					
일반병동	504	92	14	-	1	65	12
완화의료	16	6	-	4	2	-	-
계	520	98	14	4	3	65	12

그리고 입원환자를 진료하기 위한 중추적 병실인 일반병동은 [표 2] 와 같이 전체 병상수의 19% 상당이 8인실로 이루어져 있는 등 전체 병상수의 96% 상당이 6인실과 8인실로 구성되어 있습니다.

[표 2] 일반병동 병상구성 현황

구분	계	1인실	4인실	6인실	8인실
병상수	504	14	4	390	96
점수율(%)	(100)	(2.8)	(0.8)	(77.4)	(19.0)

한편 국민건강보험 요양급여 기준에 따라 건강보험 적용 기준이 4인실로 변경되었으며, 메르스 사태 이후 환자들이 의료기관 감염에 안심하고 이용할 수 있도록 감염관리를 위한 환경 구축을 위해 입법예고(보건복지부공고 제2016-493호)된 시설기준에는 “하나의 병실에 설치하는 병상은 최대 4병상”(요양병원은 6병상)으로 제한하는 내용이 포함되어 있습니다(실제 적용은 신축, 증축, 개축, 또는 재축하기 위해 건축법 제11조에 따른 건축허가를 받은 경우부터 적용)

따라서 입원 대기환자 수 등 진료적 관점, 감염병 예방, 환자의 편의, 병원 경영에 미치는 영향 등을 종합 고려하여 중장기적인 관점에서 병실당 병상 운영 기준을 검토할 필요가 있습니다.

나. 간호인력 배치에 관한사항

!!병원에서는 '16.3분기 현재 간호인력 수에 따라 차등 수가가 적용되는 일반 병동은 3등급을, 중환자실은 8등급을, 완화의료는 3등급을 각 각 적용받고 있습니다.

[표 3] 간호 차등수가 적용 현황

0. 일반병동

분기별	병상수	간호사수	비율	적용등급	적용등급 최소인원대비	상위등급 필요인원
15.1	524	134	3.91	4		
2	524	134	3.91	4		
3	524	154	3.4	3		
4	508	150.33	3.37	3		
'16.1	505.33	147.67	3.42	3	3.25	20.78
2	504	146.67	3.43	3	2.67	21.33
3	504	147.67	3.41	3	3.67	20.33

0. 중환자실

분기별	병상수	간호사수	비율	적용등급	적용등급 최소인원대비	상위등급 필요인원
15.1	27	15	1.8	8		
2	27	16	1.68	8		
3	27	15.67	1.72	8		
4	27	14.33	1.88	8		
'16.1	26.33	14	1.88	8	-	7.07
2	26	14	1.85	8	-	6.8
3	26	14	1.85	8	-	6.8

0. 완화의료

분기별	환자평균	간호사수	비율	적용등급	적용등급 최소인원대비	상위등급 필요인원
'15.4	9.9	8	1.23	2	1.4	1.9
'16.1	8.96	8	1.12	2	2.02	0.96
2	7.74	8	0.96	1	2.84	-
3	12.21	8	1.52	3	2.84 ↑	0.14

배치되는 인력에 따라 차등수가가 적용되는 부문에 대해서는 주기적으로 적용기준을 점검하여 인력을 조정 배치함으로써 병원경영에 도움이 될 수 있도록 관리하여야 합니다.

그런데 '16.3분기의 경우 일반병동에는 간호인력 147.67명을 배치하여 3등급을 적용받았는데, 이는 적용받은 등급 최소 인력대비 3.67명 상당을 많이 배치한 결과인데 반하여, 완화의료는 8명의 간호인력을 배치하여 3등급을 적용받았는데 이는 상위등급인 2등급 최소인원을 기준할 때 0.14명만이 부족한 인원으로 확인되어 향후 배치 인력수에 따라 차등수가가 적용되는 부문에 대해서는 주기적으로 배치인력 점검이 필요한 실정입니다.

다. KK사 인력 운용

!!병원에서는 입원환자의 영양상담, 환자들의 건강회복을 위한 최적의 식사 제공 등을 위하여 [표 4] 와 같이 KK사 인력을 운용하고 있습니다.

[표 4] KK사 인력 현황

직급	성명	직책	입사일	비고
FF직	***	--	'00. 3. 1.	육아휴직('16. 8.21.~'18. 2. 2.)
FF직	***	--	'11. 3. 3.	
FF직	***	--	'14. 1. 1.	
DD직	***	--	'16. 8.22.	육아휴직 대체인원('16. 8.22.~'17. 8.20.)

국민건강보험 요양급여 기준에는 입원한 환자들에게 일반식을 제공하기 위해서는 병원급에서는 2명이상의 KK사를 보유하도록 되어있으며, 치료식 수가는 KK사 인력 보유수준에 따라 차등수가를 적용(KK사 3~5명 620원, 6~9명 830원 등)하여 오다 '15.10. 1. 적용 기준이 변경되어 KK사 1명당 1일평균 치료식 환자수 40명 이하를 관리할 경우에 한해 치료식영양관리료 1일 1,000원을 인정하는 것으로 되었습니다.

이에 따라 3명의 KK사를 운영한 !!병원에서는 '15.9월까지의 치료식 가산 620원을 적용받았으나, 치료식 수가 적용기준이 변경된 후부터는 !!병원에서 1일 평균 치료식을 제공하는 환자가 250명 상당이어서 KK사 1인당 치료식 환자 84명으로 40인 기준을 초과함에 따라 가산수가를 적용받지 못하고 있습니다.(치료식 영양관리료 적용을 위해서는 KK사 6.25명 필요)

또한 '16. 9. 1.부터는 조리업무 전체를 외부 위탁하였으며, 위탁업체 KK사도 1일평균 2명이 상주하고 있는 것으로 확인되어 식대수가, 조리부문 위탁 등 TT 실 환경 변화에 따른 업무량 변화 등을 반영하여 중·단기적으로 KK사 인력운영 방향을 재검토 할 필요가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ !!병원장은

- 입원 환자 추이, 병상가동율 등을 고려하여 중장기적인 관점에서 병실당 병상 운영 기준을 재검토하여 주시고**(통보)**
- 배치 인력수에 따라 차등수가가 적용되는 부문에 대해서는 주기적으로 배치 인력 점검을 통하여 효율적으로 인력 운영이 될 수 있도록 조치하며**(통보)**
- KK사 인력운영 방향을 재검토하여 주시기 바랍니다.**(통보)**